

Tanı ve Muayene Sanatı

1. Tanı Sanatı

Tanı, sağlık sorunlarını, nedenlerini ve doğasını tespit etme ve ayırt etme bilimidir. Doğru bir tanı, başarılı tedavinin temelini oluşturur.

- **Tanının Amacı:** Hastanın sorununu ve nedenini belirleyerek uygun tedaviye yönlendirmek. "Tüm 'nedenler' cevaplanmadıkça uygun bir tedavi önerisi yapılamaz."

- **Veri Toplama ve Yorumlama:** Sadece objektif verileri ve sübjektif bulguları toplamak yeterli değildir; bu verilerin "önemli olanın ne olduğunu ve neyin sorgulanabilir olabileceğini belirlemek için yorumlanması ve işlenmesi gerekir." Örneğin; hastanın "ağrım var" şikayeti çok geniş ve yoruma açıktır. Nasıl bir ağrı? Soğuk bir şeyler tükettikten sonra kısa süreli keskin bir ağrı sadece hassasiyet sorunu olabilir. Sıcak soğuk bir şeyler tükettikten sonra birkaç dakika süren ağrı derin bir çürük kaynaklı olabilir. Bazen daha uzun süren ağrılar dişte çürük kaynaklı kontak noktasındaki kırık bölgeye yemek artığı birikmesi kaynaklı da olabilir. Spontan ve uzun süreli ağrılar, geceleri artan ağrılar ise irreversible (geri dönüşümsüz) pulpitis kaynaklı olabilir. Bazen ağrının nedeni yüksek bırakılmış bir dolgudan kaynaklanan okluzal travma olabilir. Bu farklı nedenlerin tedavileri farklıdır.

- **Klinisyen-Hasta Diyaloğu:** Klinisyen ile hasta arasında aktif bir diyalog, doğru soruları sormak ve yanıtları dikkatlice yorumlamak esastır.

- **Tanı Sürecinin Beş Aşaması:**

1. Hasta, tavsiye alma nedenlerini klinisyene bildirir.

2. Klinisyen, hastaya semptomlar ve ziyaretine yol açan geçmiş hakkında sorular sorar.

3. Klinisyen, objektif klinik testler yapar. (Örneğin perküsyon, palpasyon, soğuk testi, elektrikli pulpa testi, teşhis periapikali, panoramik röntgen...)

4. Klinisyen, objektif bulguları (klinik testler) sübjektif detaylarla (hasta ifadeleri ve hekimin kişisel deneyimi) ilişkilendirir ve olası ayırıcı tanılar listesi oluşturur.

5. Klinisyen, muhtemel tanılar arasından en uygun teşhisi seçer.

2. Ana Şikayet ve Hasta Geçmişi

Hastanın ana şikayeti ve detaylı geçmiş bilgileri, tanı sürecinin başlangıç noktasıdır.

- **Önemli İpuçları:** Hastaların klinisyene danışma nedenleri, "klinisyenin doğru tanı koymasına yardımcı olacak ilk önemli ipuçları" olarak hizmet eder. Muayenede en

önemli şey hastanın ana şikayetidir. Hekim asla hastanın ana şikayeti dışındaki konuları ana odak yapmamalıdır. Örneğin hasta anterior bölgede gözüken bir çürüğünden kaynaklı estetik şikayeti ile gelmişken hastanın posterior bölgede semptomsuz kronik bir lezyonu var diyelim. Hasta estetik kaygısını görmezden gelip posteriordaki lezyona odaklanmak klinisyenin hastanın güvenini kaybetmesine neden olacaktır. Hasta bu durumda hekim tarafından anlaşılmadığını ve sorunlarının görmezden gelindiğini düşünecektir. Hekim elbette hastaya lezyon hakkında gerekli bilgilendirmeyi yapmalıdır ancak daima ana odak hasta şikayeti olmalıdır.

- Belgeleme: Hastanın ana şikayeti, "hastanın kendi kelimeleriyle" uygun şekilde belgelenmelidir.
- Kapsamlı Kayıt: Hastanın gelişte tıbbi ve dental geçmişi içeren "kapsamlı bir kayıt" doldurması önemlidir.

2.1. Tıbbi Geçmiş

Sistemik durumlar ve ilaçlar, dental semptomları etkileyebilir veya taklit edebilir ve tedavi planını değiştirebilir.

- Klinisyenin Sorumluluğu: Her hastadan "uygun bir tıbbi geçmiş alma sorumluluğu klinisyene aittir."
- Gözden Geçirme ve Güncelleme: Form hasta tarafından doldurulduktan sonra klinisyen tarafından gözden geçirilmeli ve imzalanmalıdır. Tıbbi geçmiş ve ilaçlar her ziyaret öncesi güncellenmelidir.
- Yaşamsal Belirtiler: Her tedavi ziyaretinde "kan basıncı ve nabız" kaydedilmelidir veya hekim tarafından kontrol edilmelidir; anksiyete veya kardiyovasküler sorunları gösterebilir. Her zaman hastanın tansiyonu ölçülemeyebilir. Ancak hekim hastada panik benzeri bir durum sezinlediğinde nabzını kontrol etmesinde fayda vardır. Hekimin tek görevi tedaviyi yapmak değildir. Hastalar insandır ve rahatlatılmaya, anlaşılma, güvende hissetmeye ihtiyaçları vardır.
- İki Perspektif: Klinisyen, sağlık anketini iki açıdan değerlendirmelidir:
 1. Dental tedaviyi değiştirmeyi gerektiren tıbbi durumlar ve mevcut ilaçlar.
 2. Oral belirtiler gösterebilen veya dental patolojiyi taklit edebilen tıbbi durumlar.
- Tedavi Modifikasyonu Gerektiren Durumlar:

Kardiyovasküler; yüksek ve orta endokardit riski, patolojik kalp üfürümü, hipertansiyon, stabil olmayan anjina pectoris, yeni geçirilmiş myokard enfarktüsü (kalp krizi), kardiyak aritmi, kontrol altında olmayan konjestif kalp yetmezliği...

Pulmoner; kronik obstrüktif akciğer hastalığı (koah) astım, tüberküloz

Gastrointestinal ve renal; son evre böbrek yetmezliği, hemodiyaliz, viral hepatit, alkolizme bağlı karaciğer hastalığı, peptik ülser, inflamatuvar bağırsak hastalığı, psedomembranoz kolit

Hematolojik; cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HIV, AIDS, diyabet, adrenal yetmezlik, hipertiroidizm, hipotiroidizm, gebelik hemorajik hastalıklar, kanser, lösemi, osteoartrit, romatoid artrit, sistemik lupus eritematosus

Nörolojik gibi ciddi tıbbi durumlar dental tedavi planında değişiklikler gerektirebilir (Kutu 1.1).

- Oral Belirtiler ve Taklit Eden Durumlar: Birçok tıbbi durum, oral belirtilere sahip olabilir (örn., stomatit, kserostomi) veya dental lezyonları taklit edebilir (örn., tüberkülozun lenf düğümü tutulumu, orak hücre anemisinde kemik ağrısı, akut maksiller sinüzit ağrısı, multiple sklerozdaki ağrı, trigeminal nevralji, anjino pektoris ağrısı...)

- Dental kökenli olmayan bir patoloji düşünülüyorsa "hastanın hekimiyle bir konsültasyon her zaman uygun olacaktır."

2.2. Dental Geçmiş

Ana şikayete yol açan olayların kronolojisi, tanı testlerini yönlendirir.

- Olayların Kronolojisi: "Ana şikayete yol açan olayların kronolojisi dental geçmiş olarak kaydedilir."

- Semptomların Detaylandırılması: Diyalog, semptomların gelişimi hakkında net ve özlü bir anlatı üretmelidir. Beş temel sorgulama yönü vardır:

- Lokalizasyon: "Ağrının kaynağı olan dişi gösterebilir misiniz?" Lokalize semptomlar, tanıyı kolaylaştırır.

- Başlangıç: "Semptomlar ilk ne zaman ortaya çıktı?" Başlangıç olayı, önemli ipuçları verebilir.

- Yoğunluk: "Ağrının şiddeti ne kadar?" Ağrıyı 1-10 arası bir ölçekte derecelendirmek, ağrının şiddetini hekimin anlamasına yardımcı olur.

- Provokasyon veya Azalma: "Semptomları ne üretir veya azaltır?" Isı, soğuk, çiğneme gibi faktörler veya ağrı kesicilerle semptomların değişimi önemlidir.

- Süre: "Semptomlar kısa sürede mi azalıyor, yoksa provoke edildikten sonra devam ediyor mu?" Uyarım sonrası semptomların süresi (saniye veya dakika cinsinden), tanıya yardımcı olur.

3. Muayene ve Testler

Objektif bulgular elde etmek için çeşitli ekstraoral ve intraoral testler kullanılır.

3.1. Ekstraoral Muayene

Hastanın genel fiziksel durumu, yüz asimetrisi ve şişlikler değerlendirilir.

- İnspeksiyon ve Palpasyon: Yüz ve boyunda "şişlik olup olmadığını belirlemek için inspeksiyon (görsel) ve palpasyon (dokunma) muayeneleri" yapılır.
- Lenf Düğümleri: Servikal ve submandibular lenf düğümlerinin palpasyonu, enfeksiyonun yaygınlığını gösterir.
- Odontojenik Şişlikler: Odontojenik kaynaklı ekstraoral yüz şişlikleri genellikle endodontik kökenlidir (örn., kanin boşluğu enfeksiyonları, bukkal boşluk şişlikleri). Periodontal şişlikler olabilir ancak neredeyse tamamen intraoraldir. Bu sebeple ekstraoral şişlikler doğrudan endodontik şüphe uyandırır.
- Sinüs Uzantıları, Fistül Ağızları: Odontojenik kaynaklı fistül ağızları yüz derisinden de açılabilir ve genellikle kök tedavisi ile iyileşir.

3.2. Intraoral Muayene

Ağız içi yumuşak dokular, şişlikler ve fistül yolları değerlendirilir.

- Yumuşak Doku Muayenesi: Gingiva ve mukozanın renk, doku anormallikleri, lezyonlar veya ülserasyonlar açısından rutin değerlendirilmesi.
- Intraoral Şişlikler: Şişlikler difüz veya lokalize, sert veya fluktuant olarak belirlenmeli ve kökeni (endodontik, periodontik veya nonodontojenik) diğer testlerle ayırt edilmelidir. Sert ve semptomsuz şişlikler lezyonun kapsülüzeye olduğunu gösterir. Hastalar endodontik ağrı şikayeti ile sık antibiyotik kullandığında bu durum görülebilir.
- Intraoral Fistül ağızları: Kronik endodontik enfeksiyonlar intraoral olarak gingival yüzeye akabilir. Fistül ağzı, bir güta-perka koni ile izlenerek enfeksiyonun kaynağı olan dişin ve kökün yeri belirlenebilir. Guta perka fistül içine yollanırken ana kaynakta hatalı teşhis olmaması için guta direnç hissedilene kadar ilerletilmeli ve ana kaynağa ulaşmalıdır.
- Palpasyon: Kökler ve apeksler üzerindeki mukozaya uygulanan dijital basınçla periradiküler anormallikler veya hassasiyet tespit edilir.
- Perküsyon: Dişlere hafifçe vurmak, periodontal ligaman iltihabını (semptomatik apikal periodontit) gösterir. "Perküsyonla ağrı, dişin vital veya nonvital olduğunu göstermez, aksine periodontal ligaman iltihabının bir göstergesidir."
- Mobilite: Diş hareketliliğindeki artış, periodontal ataşman aparatının tehlikeye girdiğini gösterir ve pulpa vitalitesini belirtmez.
- Periodontal Muayene: Periodontal cep derinliklerinin ölçümü, ataşman kaybını gösterir. İzole dikey kemik kaybı endodontik kökenli olabilir. Furkasyon kemik kaybı da kaydedilmelidir.

3.3. Pulpa Testleri

Pulpa durumunu belirlemek için elektriksel, mekanik veya termal uyaranlar kullanılır.

- Termal Testler:

- Soğuk Testi: Birçok klinisyen tarafından birincil test olarak kullanılır (örn., buz, donmuş CO₂, soğutucu spreylar). "Normal yanıt, bir hissin hissedilmesi ancak termal uyaran çıkarıldıktan hemen sonra kaybolmasıdır." Anormal yanıtlar arasında yanıt olmaması, ağırlı hissin devam etmesi veya yoğunlaşması yer alır.

- Isı Testi: Hastanın sıcak gıdalara karşı yoğun ağrı şikayeti olduğunda faydalıdır. "Tipik olarak, ısıya yanıt veren ve ardından soğukla rahatlayan bir dişin nekrotik olduğu bulunur." Unutulmamalıdır ki irreversible bir pulpitiste ilk zamanlar soğuk ağrıyı provoke ederken ilerleyen süreçte sıcak etmeye başlar. Aynı zamanda soğuk ağrıyı kısa süreliğine dindirici etki de yapabilir.

- Elektrik Pulpa Testi (EPT): Pulpal sinir liflerinin varlığını gösterir ancak pulpa dokusunun histolojik sağlığını yansıtmaz. Yanıt "var veya yok" olarak puanlanır. Yanlış-pozitif ve yanlış-negatif yanıtlar mümkündür. EPT'nin güvenilir olması için komşu dişler veya simetrik diş ile kıyaslanmalı ve soğuk testi ile kombine edilmelidir.

- Yeni Nesil Teknolojiler:

- Lazer Doppler Flowmetri (LDF): Pulpal kan akışını değerlendirir ve objektif bulgulara dayanır, özellikle lüksasyon yaralanmalarında değerli olabilir.

- Pulse Oksimetri: Kan oksijen konsantrasyonunu ve nabız hızını ölçer. Pulpa sağlığını değerlendirmede geleneksel testlere göre daha doğru olabilir, ancak mevcut cihazlar hala kullanışlılık sorunlarına sahiptir.

3.4. Özel Testler

- ısırma Testi: Çiğneme sırasında ağrısı olan hastalarda hangi dişin veya kısmın hassas olduğunu lokalize etmeye yardımcı olur. Çatlamış diş veya kırık bir tüberkül, genellikle ısırma basıncının serbest bırakılmasıyla ağrıya neden olur. Çatlak dişler klinikte gözle ayırt edilemez olabilir. Ağız içinin ıslak durumu çatlak hattının izlenememesine neden olur. Bu durumda radyografilerde de belli olmayan bu ağrının kaynağını bulmakta hastaya pamuk benzeri bir cismi ısırtarak sırayla dişleri kontrol etmek klinisyen açısından hayat kurtarıcı olabilir.

- Test Kavitesi: Diğer testler sonuçsuz kaldığında veya uygulanamadığında, invaziv ve geri dönüşümsüz bir testtir. Anestezi uygulanmadan yapılan bir kavite preparasyonu sırasında ağrı hissedilmesi, pulpanın bir kısmının vital olduğunu gösterir.

- Boyama ve Transillüminasyon: Yüzeydeki çatlakları veya kırıkları tespit etmek için metilen mavisi boya veya fiberoptik ışık kullanılabilir. Kırıklar, ışığı bloke ederek karanlık görünür.

- **Selektif Anestezi:** Semptomlar lokalize edilemediğinde veya yayıldığında, özellikle hastanın hangi çeneden ağrı geldiğini belirleyemediği durumlarda faydalıdır.
-

4. Radyografik Muayene ve Yorumlama

Radyograflar, endodontik tanı ve prognoz değerlendirmesinde önemli bilgiler sağlar ancak tek başına tanı koymak için yeterli değildir.

- **Entegre Yaklaşım:** Radyografik görüntü "sadece bir işaret olarak kullanılmalı, tanısal araştırmada önemli ipuçları sağlamalıdır." Tek başına radyografiye dayalı tanı, yanlış yorumlamalara yol açabilir.
 - **Sübjektivite:** Endodontik patolojinin radyografik görünümü "bazen oldukça sübjektif olabilir."
 - **İki Boyutlu Görüntünün Sınırlamaları:** Geleneksel iki boyutlu radyograflar, anatomik yapıların üst üste binmesi ve kemik korteksinin yoğunluğu nedeniyle patolojinin erken tespiti ve lokalizasyonunda sınırlıdır. Kemik kaybı, kortikal kemiğe ulaşana kadar fark edilmeyebilir.
 - **Dijital Radyografi:** Daha düşük radyasyon dozları, anında görüntüleme, kolay manipülasyon ve depolama avantajları sunar. Görüntüler büyütülebilir ve geliştirilebilir (Şekil 1.26).
 - **Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (CBCT):** Üç boyutlu görüntüleme sağlayarak geleneksel radyografların sınırlamalarını aşar. Kemik yoğunluğu, kemik kaybı, periapikal lezyonlar, kök kırıkları ve anatomik yapıların daha doğru değerlendirilmesine olanak tanır. "CBCT, geleneksel dental radyografinin yerini almamalı, aksine tanısal bir yardımcı olarak görülmelidir."
 - **Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI):** İyonlaştırıcı radyasyon olmadan hem sert hem de yumuşak doku görüntülemesi sunar, ancak endodontide kullanımı hala yoktur.
-

5. Çatlaklar ve Kırıklar

Dişlerdeki çatlak ve kırıkların tanısı, belirtilerin çeşitliliği nedeniyle zorlayıcıdır ve prognozu doğrudan etkiler.

- **Kategori Sınıflandırması:**
 - **Craze Çizgileri:** Dentini geçmeyen, yüzeyel mine çatlaklarıdır. Genellikle semptomsuz olup tedavi gerektirmezler.

- Kırıklar (Çatlaklar): Dentin içine derinlemesine uzanan, genellikle meziyalden distale marginal sırtları içeren çatlaklardır. Doku ve transillüminasyonla görülebilir. Ağrı şiddeti değişebilir. Tedavisi kırığın kapsamına ve yönüne bağlıdır.

- Split Diş/Kökler: Bir kırığın dişi iki ayrı parçaya ayırdığı durumlardır. Kırık kemik seviyesinin altına uzanıyorsa, diş restorasyon yapılamaz hale gelebilir ve endodontik tedavi başarılı olmayabilir.

- "Çatlak Diş Sendromu" Terminolojisinden Kaçınma: Kırık köklerin sunduğu çok sayıda belirti ve semptom nedeniyle, "çatlak diş sendromu" teriminden kaçınılmalıdır, çünkü kesin bir objektif tanı koymak zordur.

- Vertikal Kök Kırıkları: Tekrarlayan endodontik patolojinin yaygın bir nedenidir, kökün uzun eksenini boyunca boylamasına uzanan ciddi çatlaklardır. Tanısı zor olabilir ve tedavinin başarısını önemli ölçüde etkiler.

- Prognoz Değerlendirmesi: Herhangi bir dental tedavi öncesinde "uygun prognoz değerlendirmesi zorunludur," özellikle çatlak dişlerde uzun vadeli başarı şüpheli olduğundan.

6. Perforasyonlar

Kök perforasyonları, tedavi başarısızlığına yol açabilen klinik komplikasyonlardır.

- Nedenleri: Geniş çürük lezyonları, rezorpsiyon veya kanal enstrümantasyonu veya post preparasyonu sırasında operatör hatası.

- Tedavi Prognozu: Boyut, konum, tanı ve tedavi süresi, periodontal hasar derecesi, onarım materyalinin sızdırmazlık yeteneği ve biyoyumluluğuna bağlıdır. Başarı, perforasyonun hemen kapatılmasına ve enfeksiyon kontrolüne bağlıdır.

7. Pulpal ve Periapikal Hastalıkların Klinik Sınıflandırması (Amerikan Endodontistler Birliği, 2016)

Klinik belirti ve semptomlar ile histopatoloji arasındaki korelasyon zor olduğundan, tedavi planı oluşturmak için klinik sınıflandırmalar geliştirilmiştir.

7.1. Pulpal Hastalık

- Normal Pulpa: Semptomsuz, pulp testlerine normal yanıt veren pulpadır. Endodontik tedavi endike değildir.

- Pulpitis: Dental pulpanın iltihabıdır; klinik olarak geri dönüşümlü veya geri dönüşümsüz olarak tanımlanır.

◦ Geri Dönüşümlü Pulpitis: İltihabın kendiliğinden geçmesi ve pulpanın normale dönmesi beklenen bir durumdur. Nedenleri arasında çürükler, açık dentin, yeni dental tedavi ve bozuk restorasyonlar bulunur. İrritanın uzaklaştırılması semptomları çözer. Dentin hassasiyetinden ayırt edilmelidir.

◦ Geri Dönüşümsüz Pulpitis: Pulpanın iyileşme kapasitesinin kalmadığı inflamatuvar durum. Tedavi, hastalıklı pulpanın çıkarılmasını gerektirir.

* Semptomatik Geri Dönüşümsüz Pulpitis: Aralıklı veya spontan ağrı, termal uyarana (özellikle soğuğa) karşı artan ve uzun süreli ağrı ile karakterizedir. Radyografik olarak periradiküler kemikte minimal veya hiç değişiklik olmayabilir.

* Asemptomatik Geri Dönüşümsüz Pulpitis: Semptomsuz olmasına rağmen, vital iltihaplı pulpanın iyileşemediği bir durumdur. Pulpa nekrozunu önlemek için endodontik tedavi en kısa sürede yapılmalıdır.

• Pulpa Nekrozu: Dental pulpanın ölümü. Pulpa testlerine genellikle yanıtıdır. Ağrı genellikle periradiküler dokulara yayıldığında ortaya çıkar. Isıya duyarlı olabilir ve soğukla rahatlayabilir.

• Daha Önce Tedavi Edilmiş: Kök kanal dolgusu ile endodontik tedavi uygulanmış dişdir. Tekrar kanal tedavisi veya cerrahi endodontik prosedürler gerektirebilir. Lezyon büyümediği takdirde 4 yıla kadar iyileşme için beklenebilir.

• Daha Önce Başlatılan Tedavi: Pulpotomi veya pulpektomi gibi kısmi endodontik tedavi uygulanmış dişdir. Pulpal tanı koymak bu aşamada mümkün değildir.

7.2. Apikal (Periapikal) Hastalık

• Normal Apikal Dokular: Semptomsuz, perküsyon ve palpasyona normal yanıt veren, radyografide intakt lamina dura ve periodontal ligaman boşluğu olan dişdir.

• Periodontit: Periodonsiyumun iltihabıdır; periapikal dokularda ise apikal periodontit olarak adlandırılır.

◦ Semptomatik Apikal Periodontit: Ağrılı ısırma, perküsyon veya palpasyon yanıtı ile karakterize apikal periodonsiyum iltihabı. Radyografide periodontal ligaman boşluğunda genişleme görülebilir.

◦ Asemptomatik Apikal Periodontit: Pulpal kökenli apikal periodonsiyumun iltihabı ve yıkımı; apikal radyolüsensi olarak görünür ve klinik semptom üretmez. Pulpa testlerine genellikle yanıt vermez.

◦ Akut Apikal Abse: Pulpal enfeksiyon ve nekroza karşı hızlı başlangıçlı inflamatuvar reaksiyon; spontan ağrı, basınca hassasiyet, püy oluşumu ve şişlik ile karakterizedir. Diş, şiddetli ağrılıdır ve pulpa testlerine yanıt vermez.

◦ Kronik Apikal Abse: Pulpal enfeksiyon ve nekroza karşı kademeli başlangıçlı inflamatuvar reaksiyon; az veya hiç rahatsızlık hissi ve ilişkili bir fistül yolu aracılığıyla

aralıklı püy akıntısı ile karakterizedir. Diş genellikle semptomsuzdur ve radyografide apikal radyolüsensi gösterir.

8. Yansıyan Ağrı

Ağrının vücudun bir kısmında hissedilmesi, ancak gerçek kaynağının başka bir uzak bölge olmasıdır.

- Tanısal Zorluk: Diş hekimliğinde, bir diştten veya kulaktan geldiği sanılan ağrı, aslında pulpal patolojili uzak bir diştten kaynaklanabilir.
 - C Lifleri: Diştten yansıyan ağrı genellikle pulpal C liflerinin yoğun uyarımıyla tetiklenir, bu da yoğun, yavaş, künt bir ağrıya neden olur. A lifleri hızlı iletim yapar ve propriyoseptif (yer konum bilgisi) duyu da taşır. Keskin ağrıdan sorumludurlar ve yerini hasta hemen hisseder. Pdl'de bulunur. C lifleri ise propriyosepsiyon yeteneğinden yoksundur. Pulpada bulunur ve hasta periapikal dokulara yansıyan bir enflamasyon kaynaklı irritana sahip değilse pulpadan kaynaklı bu ağrının yerini tam olarak gösteremez. Ağrıyı komşu dişlerle veya alt üst çenenin ilgili tarafı ile karıştırabilir.
 - Lokalizasyon Yeteneği: Hastaların ağrının tam yerini ayırt etme yeteneği sınırlıdır. "Yüksek rahatsızlık seviyelerinde, hastaların ağrının kaynağını doğru bir şekilde belirleme yeteneği azalır."
 - Klinisyenin Rolü: Yansıyan ağrı dental tanıyı karmaşıktırabileceğinden, klinisyen "hastayı gereksiz dental veya tıbbi tedaviden korumak için doğru bir tanı koyduğundan emin olmalıdır." Odontojenik olmayan ağrı durumunda hasta, orofasiyal ağrı kliniğine yönlendirilmelidir.
-

9. Sonuç

Endodontik tedavinin başarısı, doğru tanıya bağlıdır. Teknolojideki ilerlemeler (mikroskoplar, apeks bulucular, dijital radyografi, CBCT) tedavinin kalitesini artırırken, "yanlış bir tanı konulursa bu gelişmeler anlamsızdır."

Endodontik tedaviye başlamadan önce şu sorular cevaplanmalıdır:

- Mevcut sorun dental kökenli mi?
- Diştin pulpal dokuları patolojik olarak etkilenmiş mi? Periodontal dokulara yansıyan bir durum mevcut mu?
- Pulpal patoloji neden mevcut?
- Prognoz nedir? Kurtarılabilir mi?
- Uygun tedavi şekli nedir?

